

Cắt Tử Cung Qua Đường Âm Đạo (để Điều Trị Sa Tạng Chậu)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Cắt bỏ tử cung qua âm đạo, kết hợp nâng đỡ đỉnh âm đạo

Khi tử cung bị sa xuống do sa tạng chậu, một lựa chọn điều trị là **cắt tử cung qua đường âm đạo** — cắt bỏ hoàn toàn tử cung qua âm đạo, **không cần rạch bụng**. Phẫu thuật này hầu như luôn được kết hợp với **treo đỉnh âm đạo** (và thường kèm thêm các can thiệp sửa chữa khác) để vùng chậu được nâng đỡ tốt sau phẫu thuật.

Về ca phẫu thuật này

Tử cung được tách rời và lấy ra qua âm đạo. Sau đó, **đỉnh âm đạo được treo** vào các dây chằng chậu khỏe của chính bạn để tránh sa lại về sau. Có thể kết hợp sửa chữa thành trước hoặc thành sau âm đạo tùy theo kết quả khám. Đường âm đạo thường mang lại **ít đau và phục hồi nhanh hơn** so với phẫu thuật qua bụng.

Những điều cần biết

- Cắt bỏ tử cung sẽ chấm dứt kinh nguyệt và khả năng mang thai.
- Nếu sa chủ yếu liên quan đến tử cung và bạn muốn **giữ lại tử cung**, phẫu thuật treo tử cung (hysteropexy) có thể là một lựa chọn — hãy hỏi bác sĩ phẫu thuật của bạn.
- Có thể kết hợp thêm một thủ thuật điều trị **tiểu không kiểm soát** nếu cần.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Cắt tử cung (Hysterectomy)

Phẫu thuật cắt bỏ tử cung.

Đường âm đạo

Thực hiện qua âm đạo, không rạch bụng.

Treo đỉnh âm đạo (Vault suspension)

Neo lại đỉnh âm đạo để giữ nâng đỡ bền vững.

Treo tử cung (Hysteropexy)

Lựa chọn thay thế giữ lại tử cung, treo mà không cắt bỏ.

Sa tạng chậu (Prolapse)

Khi các tạng vùng chậu sa xuống gây cảm giác phồng hoặc nặng tức.

Gạc âm đạo (Vaginal packing)

Gạc đặt tạm thời sau phẫu thuật để hỗ trợ lành thương.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê/gây tê, nên bạn không cảm thấy đau trong lúc mổ. Vì không rạch bụng, thời gian hồi phục thường dễ chịu hơn các đường mổ khác — bạn có thể bị đau nhẹ đến vừa, và hầu hết bệnh nhân về nhà trong ngày hoặc sau một đêm nằm viện.

Cách chuẩn bị

- Làm theo **hướng dẫn gây mê/gây tê** (nhịn ăn, ngưng thuốc làm loãng máu theo chỉ dẫn).
- Khám tiền phẫu; thảo luận về việc có kết hợp thêm sửa chữa thành âm đạo hoặc thủ thuật trị tiểu không kiểm soát không.
- Không hút thuốc; sắp xếp người đưa về và hỗ trợ tại nhà.

Quá trình phẫu thuật

- 1 Bạn được gây mê/gây tê; kháng sinh được dùng trước mổ.
- 2 Tử cung được tách rời và lấy ra **qua âm đạo**.
- 3 Đỉnh âm đạo được **treo** vào dây chằng; các sửa chữa đi kèm được thực hiện theo kế hoạch.
- 4 Ống thông và đôi khi gạc âm đạo được đặt tạm thời.

Sau phẫu thuật

- Ra dịch hồng nhạt vài tuần là bình thường trong khi đỉnh âm đạo lành thương.
- **Tránh nâng vật nặng, rặn mạnh và quan hệ tình dục khoảng 6 tuần.**
- Giữ phân mềm, tránh rặn; nghỉ ngơi rồi tăng dần hoạt động.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh, hoặc chảy máu nhiều
- **Không đi tiểu được**, hoặc đau vùng chậu/bụng ngày càng tăng
- Dịch hôi từ âm đạo, hoặc bất kỳ thứ gì lòi ra qua âm đạo

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Cắt tử cung qua âm đạo lấy bỏ tử cung qua đường âm đạo (không rạch bụng) và kết hợp treo đỉnh âm đạo.
2. Phẫu thuật chấm dứt kinh nguyệt và khả năng mang thai; nếu muốn giữ tử cung, hãy hỏi về phương án treo tử cung.
3. Tránh nâng nặng và quan hệ ~6 tuần; ra dịch hồng là bình thường. Gọi ngay nếu sốt, chảy máu nhiều, hoặc không tiểu được.